

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	肝癌 Hepatoma				
編號	A31000-Q03-W-K07	制定者	緩和林佩瑜	公布日期	97 年 05 月 31 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	114 年 10 月 08 日
版本/總頁數	第 3.8 版/12 頁	審查者	曾翊鍵	檢閱日期	114 年 10 月 08 日

一、目的

讓護理人員了解肝癌的定義、症狀、常見檢查、常見治療、護理問題與措施及衛教指導，有更適切之照護能力，提供最佳服務品質。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）定義

大多數肝癌病人都有慢性肝病的病史，當肝細胞突變，呈現不停分裂狀態，逐漸破壞正常的肝組織，甚至轉移至身體其他器官，進而破壞之，最後危及性命的一種疾病。依組織可劃分為肝細胞癌及膽管癌兩種，前者發生率約為後者的 15-20 倍，而一般我們稱的肝癌指的就是肝細胞癌。

（二）症狀

肝癌在早期階段是沒有症狀的，幾乎感覺不到任何的不適，常會延誤了最佳治療時機，常見症狀有食慾不振、體重減輕、倦怠、腹部疼痛不適、肝臟腫大、黃疸等。末期則可能出現腹水、食道靜脈曲張、可能隨時會有吐血情形。到死亡平均只有三至六個月，因此早期診斷，早期治療，才可以延長肝癌患者的存活率。

（三）常見檢查

- 1.腹部超音波(Abdominal echo)。
- 2.血中甲型胎兒蛋白(AFP)。

主題名稱	肝癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K07	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	2/12

- 3.肝臟穿刺術(Liver biopsy)。
- 4.電腦斷層掃描(Computerized Tomography)。
- 5.X-ray。
- 6.血管 X 光顯影術(angiography)。
- 7.切片檢查(biopsy)。
- 8.磁共振造影(Magnetic Resonance Imaging)。

(四) 常見治療

1. 手術/肝移植

手術是肝癌唯一根治性的治療，進行肝切除術時，確定病人的基礎肝功能非常重要，然而，大多數病人在疾病發現時因為肝功能不佳（75%以上的病人有潛在的慢性肝病）、兩側肝葉疾病或肝外轉移而無法切除。因此，肝癌的整體可切除率只有 10-25%。如果肝癌無法切除預後很差，平均存活期(mean survival)只有幾個月。即使接受手術切除的病人，5 年復發率高到 83%。另接受肝臟移植的肝細胞癌病人術後 5 年存活率為 75~80%，復發風險約 15%。

2. 非手術治療

非手術性治療可以是局部區域性的，包括經皮穿刺腫瘤內酒精注射 (Percutaneous Ethanol Intratumor Injection；PEIT)、射頻腫瘤燒灼術 (radiofrequency tumor ablation; RFA) 或動脈栓塞 (transcatheter arterial embolization；TAE)。

3. 全身性治療

當區域淋巴轉移或是肝外轉移，局部區域性治療就不適合，當主要門脈系統受到侵犯時，動脈栓塞也不適合。對無法接受上述這些治療的病人，通常會考慮全身性化療。

4. 免疫治療和標靶藥物合併療法。

5. 藥物治療

主題名稱	肝癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K07	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	3/12

(1) 標靶藥物：Sorafenib (NEXAVAR®)、Lenvatinib (LENVIMA®)、Bevacizumab (AVASTIN®)等。

(2) 白蛋白補充、利尿劑。

(3) 止血用藥：Sandostatin、Tranexamic acid、Katimin (Vit K1)等。

(4) 腸胃道用藥：Neomycin、Gascon、Lactulose、Primperan 等。

6. 輸血治療

當病人發生食道靜脈曲張或腸胃道出血情形，輸血以補充流失量。

7. 飲食治療

(1) 採『適當蛋白質』、『高熱量』、『低脂肪』之飲食。

(2) 當病人出現肝昏迷或意識混亂者，須限制蛋白質的攝取。

(3) 禁止酒精攝取。

(4) 補充綜合維他命。

(5) 腹水的病人，應食用低鈉飲食，並限制水份一天不超過 1500-2000cc。

(6) 有食道靜脈曲張應避免粗糙堅硬食物，食用冷、軟食並注意細嚼慢嚥。

(7) 末期病人飲食以可進食為主。

(五) 常見護理問題

1. 長期意識混亂。

2. 皮膚狀態不完整：皮膚搔癢。

3. 體液容積太多。

4. 出血、血小板、血紅素減少：易受傷害。

5. 疼痛不適。

6. 心理靈性照護需求：如無望感、可能性哀傷反應、失去因應能力等。

(六) 護理措施

1. 長期意識混亂

(1) 測量生命徵象，觀察其意識型態。

(2) 監測其血液檢查值。

主題名稱	肝癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K07	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	4/12

- (3) 給予床欄使用，教導家屬在旁陪伴，注意安全。
- (4) 藉由語言，冷靜及關懷的態度，以提供病人安全的保證。
- (5) 減少環境的刺激。
- (6) 對病人表同感及正向尊重。
- (7) 必要時依醫囑來約束病人。
- (8) 提供病人定向感。

2. 皮膚狀態不完整：皮膚搔癢

- (1) 評估病人搔癢的原因。
- (2) 衛教病人儘量不要在太陽下曝曬。
- (3) 衛教病人及家屬個人衛生的重要性，並協助維護病人身體的清潔。
- (4) 衛教病人當皮膚癢時勿搔抓，以免破皮，可以輕拍皮膚來改善。
- (5) 病人意識混亂時，提供手套或約束以預防搔癢。
- (6) 衛教勿使用熱水洗澡，且使用中性的香皂。
- (7) 建議使用潤滑劑保護皮膚和維持適當的水份。
- (8) 依醫囑給予抗組織胺和止癢藥物。
- (9) 協助病人剪短指甲。
- (10) 維持衣物床褥的通風及乾淨。
- (11) 建議穿較易吸汗的棉質衣服。

3. 體液容積太多

- (1) 每天量體重。
- (2) 監測攝入量、排出量和尿比重，監測檢驗值。
- (3) 依病情限制水份、鹽份攝取量，並衛教其重要性。
- (4) 依醫囑給予利尿劑。
- (5) 評估周邊水腫、呼吸音、生命徵象。
- (6) 依醫囑給予肌肉收縮劑或血管擴張劑。
- (7) 監測動脈血氣體分析和胸部 X 光。

主題名稱	肝癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K07	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	5/12

- (8) 依醫囑給予氧氣。
- (9) 改變姿勢，以減輕呼吸困難。
- (10) 抬高水腫部位。
- (11) 給予被動與主動的關節運動。
- (12) 水腫部位，提供適當的皮膚照顧。

4. 出血、血小板、血紅素減少：易受傷害

- (1) 避免使用阿斯匹靈的製劑。
- (2) 避免挖鼻孔和擤鼻涕。
- (3) 避免任何引起創傷的情況，例如劇烈活動、與粗糙面的摩擦。
- (4) 使用軟毛牙刷，避免傷害牙齦。
- (5) 執行侵入性治療，例如抽血時，應延長壓迫止血時間，至完全止血為止。
- (6) 監測生命徵象、意識狀態之變化及出血表徵。
- (7) 評估且去除病人的危險因子：精神狀況、活動時之耐力。
- (8) 評估去除環境的危險因子，如：當病人臥床時，隨時圍上床欄、病床輪子固定、漸進式活動、穿不會滑的拖鞋，並鼓勵至少一位家屬陪伴。
- (9) 隨時陪伴病人、衛教家屬及病人如何使用呼叫鈴。
- (10) 指導有關出血的預防和症狀評估。
- (11) 告知病人及家屬對於早期出血的處理方法如：平躺休息，不要亂動、壓迫出血處、儘快通知醫護人員處理。

5. 疼痛不適

- (1) 執行詳細的疼痛評估，包括部位、特性、起始/持續時間、頻率、性質、疼痛強度或嚴重度，以及其他相關因素。
- (2) 觀察病人不舒適的言語與非語言行為。
- (3) 確保病人有接受適當之止痛照護。
- (4) 運用治療性的溝通策略，以了解病人的疼痛經驗，並表達對病人疼痛反應的接受。

主題名稱	肝癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K07	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	6/12

- (5) 確認病人的疼痛經驗對其生活品質所造成的衝擊，例如：睡眠、食慾、活動、認知、情緒、人際關係、工作表現及角色責任。
 - (6) 適當地評估病人與疼痛相關之過去經驗，包括慢性疼痛的個人或家族史或疼痛引起之失能。
 - (7) 與病人及照護團隊共同評估病人過去曾使用過之有效的疼痛控制措施。
 - (8) 協助病人及家屬尋求及提供支持。
 - (9) 提供疼痛相關的資訊，例如：引起疼痛的原因、疼痛持續時間及在某些過程中可能出現的不適感。
 - (10) 減少或排除可能引發或增強病人疼痛經驗的因子，例如：害怕、疲乏、單調及認知缺失等。
 - (11) 當選擇疼痛緩解措施時，考慮病人的參與意願、參與能力、喜好、重要親友對此方法的支持及禁忌症等。
 - (12) 選擇疼痛緩解措施時，須考慮疼痛的型態及位置。
 - (13) 鼓勵病人自我監測疼痛的情形，並適度地予以調整。
 - (14) 配合處方的止痛藥，以提供病人最理想的疼痛緩解。
 - (15) 持續地評估病人的疼痛經驗，以評值疼痛控制措施的成效。
 - (16) 促使病人獲得充足的休息/睡眠以協助疼痛的緩減。
 - (17) 適當地鼓勵病人討論其疼痛經驗。
 - (18) 當使用疼痛緩解方法無效或病人對其疼痛之抱怨不同於往常時，通知醫師做適度的處理。
 - (19) 儘可能地將家屬納入病人疼痛緩解處置計劃中。
 - (20) 定期地監測病人對疼痛處置之滿意度。
6. 心理靈性照護需求：如無望感、可能性哀傷反應、失去因應能力等
- (1) 接納病人孤寂和無望感的情緒表達。
 - (2) 傾聽病人的感受，陪伴支持情緒宣洩。
 - (3) 真誠的關懷對病人的感受表達出同感心。

主題名稱	肝癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K07	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	7/12

- (4) 協助病人生命回顧，重新體會生命新的意義及價值。
- (5) 協助病人運用冥想、禱告或其他宗教傳統和儀式。
- (6) 依照病人的喜好提供其想要的精神支持物品（例如：十字架、佛像照片或經文、聖經等）。
- (7) 向病人保證症狀會努力控制。

（七）衛教指導

1.上腸胃道出血的預防方法

- (1) 營養要均衡，多吃高營養、高蛋白的食物。
- (2) 採取少量多餐的飲食習慣。
- (3) 避免暴飲暴食。
- (4) 吃飯要定時，上班、上學的人最好早起，從容的吃早餐。
- (5) 少吃刺激胃酸分泌增加的食品，如太辣、太鹹的食物，汽水，茶等。
- (6) 進食時需充分咀嚼，緩慢進食，飯後應有短時間的休息。
- (7) 避免抽煙、喝酒、喝咖啡。
- (8) 每天應有一定的休息時間、睡眠、避免熬夜。
- (9) 每天應有適當的休閒娛樂，以放鬆緊張心情。
- (10) 避免高壓力的工作或工作過度勞累。
- (11) 不要亂服用止痛劑及類固醇、水楊酸類的藥物。
- (12) 瞭解出血復發之徵象：

吐血、解黑便、昏厥、口渴、恐懼坐立不安、呼吸困難等、若有復發的情形、應儘早就醫、定期接受檢查可防止再復發的機會。

2.飲食衛教

- (1) 適當蛋白質及熱量：

重要性：可避免蛋白質攝取過多無法代謝，導致肝性腦病變

A. 儘量攝取動物性蛋白質，例如：雞蛋、牛奶、瘦肉。但乳酪奶酥不宜多吃。

主題名稱	肝癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K07	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	8/12

B. 每日所需的熱量可由下列含熱量高，且蛋白質極低之食物供給，如：

糖、蜂蜜、粉條、水果，並減少由高脂肪食物獲得熱量，例如：肥肉、油炸食物、花生、腰果、蛋糕應減少脂肪攝取。

C. 急性期之肝性腦病變病人須禁止攝取蛋白質。

(2) 低鈉飲食：

重要性：避免水腫、腹水產生

A. 減少使用含鈉調味品，例如：鹽、烏醋、豆瓣醬、味精、醬油、蕃茄醬、沙茶醬、味噌。

B. 避免加鹽製成的加工品及醃製食品，例如鹹麵包、冷凍蔬菜、鹹餅干、洋芋片、鹹蛋、皮蛋、泡菜、醃肉、臘腸、豆腐乳、醬菜、板鴨、榨菜、冷凍蔬菜。

C. 烹調美味的低鈉飲食：

(A) 酸味：使用白醋、檸檬、蘋果、鳳梨、蕃茄等，可增加酸味。

(B) 糖醋：可利用糖醋來調味，增加食物酸甜的風味。

(C) 甘美：利用香菇、海帶、香菜來增加食物美味。

(D) 中藥材利用：甘草、當歸、黑棗、紅棗、枸杞。

(E) 強烈風味蔬菜及調味料利用：使用蒜、蔥、薑、八角胡椒、香草片等味道較強的物品添增食物風味。

(F) 利用烤、蒸、燻、燉來增添味道。

(G) 低鹽調味品利用：可運用薄鹽醬油或低鈉鹽來代替調味。

3.併發症及如何預防：

(1) 門脈高壓及食道靜脈曲張：

A. 避免用力動作，會增加腹壓及胸壓。

B. 避免進食粗食物，會造成食道損傷。

C. 避免進食辛辣食物，會造成食道黏膜損傷。

D. 有出血現象前應擬定緊急救護計劃。

主題名稱	肝癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K07	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	9/12

(2) 腹水及水腫：

- A. 服用醫師所開的藥物，例如：利尿劑、白蛋白。
- B. 飲食採取低鈉及限制液體的攝取。
- C. 除非是有肝性腦病變，否則可攝取適量蛋白質。
- D. 每天量腹圍、磅體重，監測體液是否滯留。
- E. 避免服用阿斯匹靈，因有些藥會刺激前列腺素分泌。
- F. 觀察皮膚彈性、水份之變化，是否有水腫現象產生。

(3) 肝性腦病變：

- A. 減少食物中蛋白質的量（20-40g／天）。
- B. 預防腸胃道出血，避免辛辣刺激的食物。
- C. 按時定量服用藥物，例如：neomycin、lactulose 以降低腸內道細菌產生氨。
- D. 其他注意事項：
 - (A) 避免便秘及用力解便。
 - (B) 有腹水產生的病人，可採半坐臥或坐臥，以利呼吸。
 - (C) 有出現下肢水腫情形，鼓勵活動和將下肢抬高，以促進靜脈回流。
- E. 有肝昏迷症狀的病人：
 - (A) 臥床休息時床欄拉上並加上護墊，防碰撞引起損傷。
 - (B) 協助口腔護理以減輕肝臭的異味。
 - (C) 安排安靜的環境避免刺激病人。

(八) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

主題名稱	肝癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K07	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	10/12

五、流程圖

(略)

六、參考資料

- (一) 陳敏銓、黃采薇、趙子傑、簡淑慧、陳秋慧、陳瑞儀...顧乃平(2017)．癌症護理學．台北市：華杏。
- (二) 吳麗彬、周繡玲、劉莉妮(2020)．消化系統疾病之護理．於劉雪娥總校閱，成人內外科護理（八版，478-484）．華杏。
- (三) Marc S. S.(2022)．麻州總醫院內科手冊（鄭昌錡、張克威、廖述寬、莊觀瑄、董鴻甯、李珩譯）．合記．（原著出版於 2021 年）。
- (四) Yang, J. D., Hainaut, P., Gores, G. J., Amadou, A., Plymoth, A., & Roberts, L. R. (2019). A global view of hepatocellular carcinoma: trends, risk, prevention and management. *Nature reviews. Gastroenterology & hepatology*,16(10), 589–604.
<https://doi.org/10.1038/s41575-019-0186-y>
- (五) Vogel, A., Meyer, T., Sapisochin, G., Salem, R., & Saborowski, A. (2022). *Hepatocellular carcinoma. Lancet (London, England)*, 400(10360), 1345–1362.
[https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(22\)01200-4](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)01200-4)

七、附件

(略)

主題名稱	肝癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K07	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	11/12

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
97.05.31	1.0	新制定	97 年 05 月 31 日護理部照護標準委員會通過
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版	
100.08.31	2.1	修改錯別字	100 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
101.08.31	2.2	1.矯正護理字詞 2.醫護部改護理部	101 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
102.02.08	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱	
103.06.30	3.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.08.31	3.1	1.第三項說明內容部份增修 2.增修第六項參考資料	104 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
105.08.31	3.2	1. 第三項第(五)、(六)目部份內容增刪。 2. 新增參考文獻出處於內文中。	105 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
106.08.31	3.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.29	3.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.09.12	3.3	第二項新增（含中興分院）。	107 年 09 月 12 日護理長會議通過
108.09.23	3.4	第三項第八目本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 09 月 11 日護理長會議通過;108 年 09 月 23 日督導會議通過公布。
109.08.18	3.5	第三項第五目之 3、第六目之 3、之 4(8)(9)說明內容文字修訂。	109 年 08 月 06 日照護標準組會議通過； 109 年 08 月 12 日護

主題名稱	肝癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K07	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	12/12

			理長會議通過;109 年 08 月 18 日督導會議通過公布。
110.08.05	3.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.09.06	3.6	1. 第三項第二、四目內容部份刪修。 2. 第三項第五、六目之護理問題修訂。 3. 刪除新增第六項參考資料。	111 年 08 月 04 日照護標準組會議通過； 111 年 08 月 10 日護理長會議通過;111 年 09 月 06 日督導會議通過公布。
112.08.03	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.09.03	3.7	1. 第三項第六目之 1、3、5 說明內容文字修訂。 2. 第三項第七目之 2(3)修訂整段為 3，說明內容文字修訂。	113 年 08 月 08 日照護標準組會議通過； 113 年 08 月 14 日護理長會議通過;113 年 09 月 03 日督導會議通過公布。
114.10.08	3.8	1. 第三項第一、三、四目、第六目之 3 說明內容文字修訂。 2. 增修第六項參考資料。	114 年 08 月 07 日照護標準組會議通過； 114 年 09 月 10 日護理長會議通過;114 年 10 月 08 日督導會議通過公布。